

L'insuffisance rénale aiguë

2025

1/ Concernant l'IRA :

- A- Elle est définie par une augmentation de la créatinine sérique
- B- Le stade 1 est caractérisé par une oligurie > 24h
- C- Elle est définie par une diminution de la diurèse
- D- Le besoin de dialyse peut justifier à lui seul une classification en stade 3
- E- Le stade 3 est le stade le plus grave

2/ Le caractère aigu de l'insuffisance rénale est certain si:

- A- On dispose de valeur antérieure normale de la créatinine datant de moins de 3 mois
- B- Les Reins sont de taille normale
- C- On ne trouve pas une anémie
- D- On trouve une hypocalcémie
- E- Il y a ultérieurement une récupération totale de la fonction rénale

3/ Parmi les mécanismes suivants, lesquels peuvent entraîner une baisse de la filtration glomérulaire ?

- A - Augmentation des résistances artériolaires afférentes
- B - Diminution des résistances artériolaires efférentes
- C - Diminution du débit sanguin rénal
- D - Diminution du coefficient d'ultrafiltration (Kf)
- E - Augmentation de la pression intra-tubulaire

4/ Concernant l'IRA fonctionnelle, lesquelles des affirmations suivantes sont exactes ?

- A - Elle est toujours due à une hypovolémie vraie
- B - Elle peut être favorisée par l'utilisation d'AINS
- C - Elle se traduit par une urine riche en sodium
- D - L'adaptation glomérulaire implique la vasoconstriction de l'artériole afférente
- E - Elle est réversible à l'arrêt de l'agression hémodynamique

5/ Concernant la nécrose tubulaire aiguë ischémique :

- A - Elle est caractérisée par une atteinte préférentielle du glomérule
- B - Elle est réversible grâce à la régénération des cellules tubulaires
- C - L'activation du feed-back tubulo-glomérulaire aggrave la vasodilatation afférente
- D - La rétrodiffusion d'urine participe à la baisse de la filtration glomérulaire
- E - La bordure en brosse des cellules proximales est conservée

6/ Concernant l'évolution naturelle de la NTA :

- A - La phase d'initiation est caractérisée par une baisse persistante du débit de filtration glomérulaire
- B - La phase de régénération tubulaire implique une prolifération cellulaire
- C - Les altérations ultra-structurales caractérisent la phase initiale
- D - La reprise de la diurèse signe toujours la récupération complète de la fonction rénale
- E - L'EGF et l'IGF-1 participent à la réparation épithéliale

7/ Les principaux mécanismes physiopathologiques impliqués dans l'IRA sont :

- A - L'autorégulation rénale est dépassée dans l'IRAF (baisse importante du PAS)
- B - La prolongation de la diminution de la perfusion rénale avec hypoxie secondaire dans la NTA ischémique
- C - L'augmentation de la pression hydrostatique dans la chambre urinaire dans l'IRA obstructive
- D - Les lésions glomérulaires avec baisse du KF dans les IRA organiques
- E - La toxicité tubulaire et interstitielle indirecte dans les NIA et les Nécroses tubulaires toxiques

8/ Le syndrome commun aux urémies aiguës peut comprendre :

- A - Une altération de l'état de conscience
- B - Une péricardite urémique
- C - Des nausées et vomissements
- D - Une hypokaliémie sévère
- E - Une encéphalopathie urémique

9/ Quels arguments retenez-vous en faveur d'une IRA devant une élévation de la créatininémie ?

- A - Une phosphatémie élevée
- B - Reins de taille normale ou augmentée
- C - Une calcémie normale
- D - Absence d'anémie
- E - Fonction rénale antérieure normale

10/ Devant toute IRA, on doit rechercher les complications suivantes :

- A- Une hypercalcémie
- B- Une hyperkaliémie
- C- Un œdème aigu pulmonaire
- D- Une alcalose métabolique
- E- Une acidose métabolique

11/ Les signes électriques de l'hyperkaliémie sont :

- A- L'élargissement des complexes QRS
- B- Le bloc auriculo-ventriculaire
- C- Le bloc sino auriculaire
- D- Une tachycardie ventriculaire
- E- Une torsade de pointe

12/ L'hyperkaliémie peut être aggravée par :

- A - Une acidose métabolique
- B - Une rhabdomyolyse
- C - L'hémolyse
- D - Les vomissements
- E - Les diarrhées

13/ Les principaux signes distinctifs entre insuffisance rénale aiguë et insuffisance rénale chronique sont :

- A - L'hypocalcémie
- B - L'anémie

C - L'hyper-uricémie

D - La mesure de la taille des reins

E - L'hypophosphorémie

14/ Quels sont les causes d'insuffisances rénale aigue avec anémie :

A - L'hémolyse

B - L'hémorragie

C - La Polykystose rénale

D - La Pancréatite aigue

E - L'Intoxication aux barbituriques

15/ Quels sont les causes d'insuffisances rénales aigues avec hypocalcémie :

A - Une Rhabdomyolyse

B - Une Sarcoïdose

C - Une Acidose sévère

D - Une Pancréatite aigue

E - Un myélome multiple

16/ Une IRC avec deux reins de taille normale ou augmentée peut se voir en cas de:

A - Un diabète

B - Une sarcoïdose

C - Une amylose rénale

D - Un myélome multiple

E - Une polykystose rénale

17/ L'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, peut être due à:

A - Des pertes hémorragiques

B - Des analgésiques

C - Une insuffisance cardiaque aigue

D - Une cirrhose décompensée

E - Un syndrome néphrotique

18/ Concernant l'IRA fonctionnelle :

A - Le symptôme majeur est l'oligoanurie

- B - L'hypertension artérielle est un signe clinique fréquent
- C - Le pli cutané et la tachycardie sont des signes évocateurs d'une hypovolémie vraie
- D - Le tableau d'une hypovolémie relative est caractérisé par la présence des œdèmes
- E - Les urines sont le plus souvent claires

19/ Les éléments biologiques suivants sont en faveur de l'insuffisance rénale aigue fonctionnelle :

- A- Une uricémie élevée
- B- Une osmolarité urinaire basse
- C- Une hémococoncentration
- D- Une natriurèse élevée
- E- Une dissociation urée-créatinine

20/ Les anomalies suivantes sont en faveur d'une IRA fonctionnelle :

- A. Un rapport Urée/ créatinine plasmatique > 60
- B. Un Na urinaire $> 20 \text{ mmol/l}$
- C. Un rapport Urée urinaire/ Urée plasmatique > 10
- D. Une osmolarité urinaire $< 250 \text{ mosm/kg}$
- E. Un rapport $\text{Na}^+\text{u}/\text{K}^+\text{u} < 1$

21/ Les médicaments pouvant être responsables d'une IRA fonctionnelle sont :

- A- Les AINS
- B- Les IEC
- C- Les antidiabétiques oraux
- D- Les anti calcineurines
- E- Les diurétiques thiazidiques

22/ Quelles sont les propositions exactes concernant les IRA organiques ?

- A- La présence d'une leucocyturie associée oriente plutôt vers une néphrite interstitielle aiguë (NIA)

B- La présence d'une HTA et d'œdèmes associés orientent vers une nécrose tubulaire aiguë (NTA)

C- La présence d'une hématurie macroscopique associée est spécifique d'une néphropathie vasculaire aiguë (NVA)

D- La présence d'une protéinurie > 2 g/24h associée oriente vers une néphropathie glomérulaire aiguë (NGA)

E- La présence d'une hématurie microscopique associée oriente vers une NGA

23/ Les indications de la biopsie rénale au cours de l'insuffisance rénale aiguë organique sont :

A - L'insuffisance rénale aiguë avec hypo-complémentémie

B - L'insuffisance rénale aiguë secondaire à un obstacle vésical

C - L'insuffisance rénale aiguë associée à une hémorragie intra-alvéolaire

D - L'insuffisance rénale aiguë secondaire à un état de choc cardiogénique

E - Une NTA avec absence de reprise de la diurèse après 3 à 4 semaines

24/ Quelle est la cause d'IRA organique la plus fréquente ?

A - Une Glomérulonéphrite Rapidement Progressive

B - Une Néphrite Interstitielle Aigue médicamenteuse

C - Un Syndrome Hémolytique et Urémique

D - Une Nécrose Tubulaire Aigue

E - Une thrombose bilatérale des artères rénales

25/ Dans une insuffisance rénale aiguë, un élément parmi les suivants est déterminant en faveur de son mécanisme organique :

A - Une natriurèse basse

B - La présence d'une hypertension artérielle

C - Les anomalies du sédiment urinaire

D - Une hyperkaliémie sévère

E - Une anurie

26/ Les principales causes d'IRA parenchymateuses par nécroses tubulaires aiguës sont :

A- Les aminosides

B- Un saignement digestif sans retentissement hémodynamique

C- Le syndrome de lyse tumorale

D- Une Précipitation intra tubulaire de paracétamol

E- Le myélome multiple

27/ Au cours de l'IRA par nécrose tubulaire :

A- La récupération de la fonction rénale antérieure est la règle

B- Il y a une hématurie fréquente

C - La protéinurie est supérieure à 3 g/24 h

D- La natriurèse est élevée

E- La diurèse est toujours conservée

28/ Les causes de rhabdomyolyse menant à une nécrose tubulaire aigue, peuvent être :

A- Une hypothyroïdie

B- Une infection virale

C- La prise d'antalgiques en fortes doses

D- La prise de statine

E- Une crise convulsive

29/ Quels médicaments peuvent être à l'origine d'une nécrose tubulaire aiguë ?

A- L'amphotéricine B

B- L'Oméprazole

C- Le Méthotrexate

D- Les sulfamides

E- La Cisplatine

30/ L'insuffisance rénale aigue par précipitation intra-tubulaire peut être secondaire à :

A - Un Syndrome de lyse tumorale

B - Une hémolyse

C - Un traitement par Aciclovir

D - Un myélome multiple

E - Un traitement par des aminosides

31/ Quels sont les médicaments pouvant être à l'origine d'une néphrite interstitielle aiguë ?

A- Les anti-inflammatoires non stéroïdiens

- B- L'Oméprazole
- C- Le Méthotrexate
- D- La Ciprofloxacine
- E- L'allopurinol

32/ Les causes suivantes peuvent engendrer une NIA :

- A - La sarcoïdose
- B - Le diabète
- C - Le syndrome de Gougerot-Sjögren
- D - Le syndrome d'hyperIgG4
- E - Le lymphome

33/ Au cours des NIA, On peut trouver :

- A- Une leucocyturie aseptique
- B- Une protéinurie abondante
- C- Un rash cutané
- D- Une hyper-éosinophilie
- E- Une HTA sévère

34/ La GNA post infectieuse est associée à:

- A- Un intervalle libre entre l'infection et l'atteinte rénale
- B- Un complément bas
- C- Un syndrome néphrotique dans tous les cas
- D- Une hypertension artérielle
- E- Un sédiment urinaire négatif

35/ Chez l'enfant, en cas de GNA, la PBR est indiquée dans les situations suivantes ?

- A - Une anurie persistante plus de 3 jours
- B - Une dégradation persistante de la fonction rénale au-delà de 3 jours
- C - Un syndrome néphrotique persistant au-delà de 2 semaines
- D - Une hématurie microscopique isolée persistante pendant plus de 6 mois
- E - Une hypocomplémentémie persistante au-delà de 12 semaines

36/ Lors d'une glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse chez l'enfant, quelles sont les propositions exactes ?

- A - La PBR est systématiquement indiquée au diagnostic
- B - Elle montre typiquement une prolifération endocapillaire exsudative non suppurative
- C - Elle met en évidence des dépôts mésangiaux d'IgG et de C3
- D - La prolifération extracapillaire avec croissants est le signe le plus fréquent
- E - Le rein est optiquement normal

37/ Au cours des glomérulonéphrites rapidement progressives, le tableau clinique est caractérisé par:

- A- Une hématurie microscopique non constante
- B- Une protéinurie d'abondance modérée < 3 g/j
- C- L'absence de l'HTA
- D- Une hémorragie alvéolaire constante
- E- Une leucocyturie aseptique

38/ Les GNRP regroupent :

- A - Les glomérulonéphrites à anticorps anti-MBG
- B - Les glomérulonéphrites extracapillaires pauci-immunes
- C - Les glomérulonéphrites extracapillaires à complexe immuns
- D - Les glomérulonéphrites aiguës post-infectieuses
- E - Les néphrites interstitielles aiguës immuno-allergiques

39/ Au cours du syndrome hémolytique et urémique (SHU), on trouve :

- A- Une haptoglobine effondrée
- B- Une thrombopénie
- C- Une anémie hémolytique auto-immune
- D- Une HTA
- E- Une Hématurie

40/ Au cours de la maladie des embolies de cristaux de cholestérol, on peut trouver :

- A- Une HTA

- B- Un livedo
- C- Une anémie hémolytique
- D- Une nécrose distale péri-unguéale
- E- Une prise d'anticoagulant

41/ Un homme de 29 ans, diabétique type 1, présente une IRA avec lombalgies intenses et hématurie macroscopique dans un contexte fébrile et signes urinaires bas. Le diagnostic le plus probable est:

- A- Une nécrose tubulaire aiguë secondaire à une hémolyse
- B- Une PNA simple
- C- Une nécrose corticale bilatérale
- D- Une nécrose papillaire
- E- Une glomérulonéphrite aiguë post infectieuse

42/ Au cours de la nécrose corticale, on trouve:

- A- Un tableau clinique d'une NTA
- B- Une reprise de la diurèse dans les délais habituels d'une NTA
- C- Un contexte étiologique particulier
- D- Une HTA sévère
- E- Un complément bas

43/ En cas d'hyperkaliémie sévère ($\geq 6,5$ mmol/L) avec signes électriques à l'ECG, quelle sera votre prise en charge en urgence ?

- A- Monitoring cardio-respiratoire
- B- Dialyse péritonéale
- C- Gluconate de calcium IV
- D- Administration de Résine échangeuse d'ions
- E- Séance d'hémodialyse en urgence

44/ Les traitements d'urgence d'une hyperkaliémie sévère sont :

- A. Le Gluconate de calcium
- B. Le Citrate de potassium

C. L'Hémodialyse

D. L'insuline

E. Les Agonistes β_2 adrénergiques

45/ Les indications d'épuration extra-rénale en cas d'insuffisance rénale aigue:

A - Un œdème aigu du poumon réfractaire aux diurétiques

B - Une hyperkaliémie à 5,1

C - Un pH à 7,15 avec bicarbonates à 10 mmol/l

D - Une oligurie

E - Une TA à 190/100 mmHg

46/ Les indications absolues de l'épuration extrarénale en urgence sont :

A - Une urée sanguine supérieure à 30 mmol/L symptomatique

B – Une hyperkaliémie à 6,5 mmol/L avec signes ECG

C – L'OAP

D – Epuration d'un toxique

E – Une protéinurie et/ou hématurie abondantes

47/ L'IRA est généralement spontanément réversible, en cas de:

A- Néphrite interstitielle aiguë

B- NTA toxiques

C- IRA obstructive

D- GNRP

E- Un syndrome hémolytique et urémique

48/ Quelle est la principale cause de mortalité élevée dans les insuffisances rénales aiguës?

A- Néphropathies glomérulaires rapidement progressives

B- IRA des NTA toxiques

C- IRA obstructive

D- IRA après un choc septique

E- IRA fonctionnelle

49/ Les facteurs de risque de la néphrotoxicité aux produits de contraste iodés sont :

- A - L'insuffisance cardiaque
- B - Prise AINS concomitante
- C - Une insuffisance rénale chronique préexistante
- D - Une hypertension artérielle
- E - Le diabète

50/ Comment prévenir l'IRA secondaire à l'injection d'iode ?

- A- Utiliser le produit iodé le plus hyperosmotique
- B- Arrêt préalable des AINS
- C- Limiter le volume de PCI administrés
- D- Hyperhydratation pendant les 12 heures avant l'examen et les 12 heures après
- E- Arrêt des IEC avant l'injection du produit de contraste

51/ L'IRA obstructive :

- A- Survient lorsque l'écoulement de l'urine est empêché par la présence d'un obstacle unilatéral.
- B- Survient si l'obstacle est bilatéral.
- C- Survient si l'obstacle sur la voie excrétrice du seul rein fonctionnel
- D- Est généralement non réversible après la libération de la voie excrétrice.
- E- peut-être consécutive à une fibrose rétro-péritonéale

52/ Au cours du syndrome de levée d'obstacle, on peut constater :

- A- Une diurèse horaire importante
- B- Une hypokaliémie
- C- Une déshydratation extracellulaire
- D- Une hyperglycémie
- E- Une hyponatrémie

53/ Devant une IRA, la cause obstructive est évoquée devant :

- A- Une anurie brutale
- B- Une hématurie macroscopique avec caillots
- C- Une diurèse à éclipse
- D- Une albuminurie
- E- Une anémie hémolytique

54/ Quels éléments orientent vers une IRA obstructive ?

- A- L'absence Globe vésical
- B- ATCD de néoplasie pelvienne
- C- Une installation progressive
- D- Une colique néphritique
- E- Un blindage pelvien au toucher vaginal et/ou au toucher rectal

CAS CLINIQUE N°1

- Une femme de 42 ans consulte pour œdèmes des membres inférieurs et prise de poids récente. À l'interrogatoire, elle rapporte une asthénie, des myalgies diffuses, et des épisodes fébriles intermittents depuis plusieurs semaines. À l'examen clinique : tension artérielle à 160/95 mmHg, présence d'un épanchement pleural modéré à droite, œdèmes mous bilatéraux des chevilles, éruption maculopapuleuse au niveau des avant-bras. Bandelette urinaire : Protéinurie+++, hématurie++

Les examens biologiques montrent : Hémoglobine : 9,8 g/dl, Leucocytes : 4800/mm³, Plaquettes : 190 000/mm³, Créatinine : 135 µmol/l, Albuminémie : 28 g/l, Protéinurie des 24h : 3 g

1. Le type d'atteinte rénale chez cette patiente est :

- A. Tubulaire aiguë
- B. Glomérulaire aiguë
- C. Fonctionnelle
- D. Obstructive
- E. Interstitielle chronique

2. Parmi les diagnostics étiologiques suivants, lesquels sont les plus probables ?

- A. Néphropathie lupique
- B. Syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse
- C. Glomérulonéphrite post-infectieuse
- D. Néphropathie à IgA
- E. Néphrite interstitielle à éosinophiles

3. Concernant la réalisation d'une ponction-biopsie rénale :

- A. Elle est indispensable pour le diagnostic et l'orientation thérapeutique
- B. Elle est contre-indiquée du fait de l'insuffisance rénale aiguë
- C. Peut être évitée si les AAN sont positifs
- D. Est utile uniquement en cas de suspicion de vascularite
- E. Ne nécessite pas de faire d'autres examens complémentaires

4. Quelle est la lésion histologique attendue dans cette situation ?

- A. Prolifération mésangiale pure
- B. Prolifération endocapillaire avec dépôts d'IgG, IgA, IgM et C3

- C. Glomérulosclérose segmentaire et focale
- D. Dépôts granuleux d'IgG et de C1q sur les capillaires glomérulaires
- E. Lésions artériolaires sans atteinte glomérulaire

CAS CLINIQUE N°2

Un homme de 66 ans, avec des antécédents d'hypertension artérielle bien contrôlée sous bithérapie, d'hypercholestérolémie, de tabagisme chronique actif et d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, est hospitalisé pour une insuffisance rénale aiguë.

Il avait subi une thrombo-endarterectomie de l'artère fémorale quatre semaines auparavant.

Il développe progressivement une hypertension artérielle sévère, une oligurie (diurèse à 500 mL/24h), une élévation rapide de la créatinine jusqu'à 498 $\mu\text{mol/L}$. Le bilan montre une protéinurie à 0,4 g/24h, pas d'hématurie ni leucocyturie à la bandelette urinaire, et une échographie rénale sans anomalies.

Questions :

1. Le type d'insuffisance rénale aiguë que présente ce patient est le plus probablement :

- A. Pré-rénale
- B. Nécrose tubulaire aiguë
- C. Vasculaire aiguë
- D. Glomérulonéphrite extracapillaire
- E. Glomérulopathie membrano-proliférative

2. Dans le contexte d'une maladie des embolies de cristaux de cholestérol, on peut retrouver les éléments suivants, SAUF :

- A. Livedo réticulé
- B. Hyperéosinophilie
- C. Complément normal
- D. Orteil pourpre
- E. Pancréatite aiguë

3. Le diagnostic de maladie des embolies de cristaux de cholestérol peut être conforté par :

- A. L'examen du fond d'œil
- B. Une biopsie cutanée ciblée
- C. Une biopsie rénale
- D. Le dosage des anticorps anti-MBG
- E. Une Biopsie des glandes salivaires

4. La prise en charge thérapeutique de cette pathologie repose sur :

- A. L'initiation rapide d'une corticothérapie forte dose
- B. Le contrôle strict des facteurs de risque cardiovasculaire

- C. L'indication d'une héparinothérapie curative
- D. Une indication de plasmaphérèse en première intention
- E. La mise en dialyse systématique dès le diagnostic posé

CAS CLINIQUE N°3

Un patient de 59 ans, hypertendu depuis deux ans et traité par ramipril (IEC), a consulté une semaine plus tôt pour des gonalgies. Un traitement à base d'AINS et de paracétamol lui a été prescrit. Il revient actuellement pour oligurie.

À l'examen clinique : TA = 130/80 mmHg

Bandelette urinaire : Leucocytes (-), Hématurie (-), Protéinurie (-)

Biologie : Urée : 32 mmol/L, Créatinine : 400 µmol/L (valeur antérieure : 80 µmol/L il y a un mois)

1) La démarche paraclinique initiale devant cette insuffisance rénale aiguë inclura :

- A. Un ionogramme urinaire
- B. Une échographie rénale
- C. Un ECBU
- D. Une urée urinaire
- E. Un uro-scanner

2) Les causes possibles d'insuffisance rénale aiguë chez ce patient sont :

- A. Une IRA organique d'origine vasculaire
- B. Une nécrose tubulaire aiguë
- C. Une IRA fonctionnelle par altération de l'hémodynamique intra-rénale
- D. Une néphrite interstitielle aiguë d'origine médicamenteuse
- E. Une glomérulonéphrite rapidement progressive

3) La prise en charge initiale de ce patient inclut :

- A. L'arrêt des AINS
- B. L'arrêt du paracétamol
- C. L'arrêt du ramipril
- D. Une perfusion intraveineuse de sérum salé isotonique
- E. L'introduction d'un cardiotonique

CAS CLINIQUE N°4

Mr A.M âgé de 52 ans, consulte les urgences pour œdèmes des membres inférieurs avec baisse de la diurèse depuis la veille. Il est diabétique et hypertendu depuis 22 ans. Son traitement comporte du Captopril (IEC) 50mgx2/j, Aspégic 100mg/j et Metformine 850mgx2/j.

A l'examen: TA= 170/85 mm Hg, auscultation pulmonaire normale, œdèmes des membres inférieurs, lésion du pied droit faisant sourdre du pus évoluant depuis 21 jours. Bandelettes urinaires: Albumine=++++ , Hématies=++++, Leucocytes=+

Bilan: Na⁺/K⁺= 132/5 mmol/l, Urée=25 mmol/l, Créatinine=600 µmol/l, HCO₃⁻= 12, glycémie= 23 mmol/l, CRP= 150, Hb=13g/dl, globules leucocytes =14500/µL, plaquettes= 185000/µL, protides totaux= 56g/l, albumine= 29g/l, calcémie= 2,3 mmol/l, complément C3 = 0.2 g/l (0,9-1,3), protéinurie = 3,5g/24h, ECBU: L= 400, H= 300 éléments/mm³

1) Ces données se résument chez ce patient dans la proposition suivante :

- A- Un syndrome néphrotique impur
- B- Un syndrome néphritique aigu
- C- Un syndrome néphritique aigu avec syndrome néphrotique
- D- Un syndrome néphrotique pur
- E- Un syndrome d'urémie aiguë

2) Le diagnostic le plus probable chez ce patient est le suivant :

- A- Une néphropathie diabétique
- B- Une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle
- C- Une néphropathie à IgA
- D- Une glomérulonéphrite aiguë post infectieuse
- E- Une néphroangiosclérose bénigne

3) Parmi les examens complémentaires suivants, lequel est prioritaire pour la prise en charge immédiate ?

- A. Un fond d'œil
- B. Une échographie rénale et vésicale
- C. Une biopsie rénale en urgence
- D. Un scanner cérébral
- E. Une scintigraphie rénale au DMSA

4) Votre conduite à tenir devant l'aggravation de l'hypertension artérielle chez ce patient comprend les éléments suivants :

- A- Une augmentation de la dose de Captopril
- B- La recherche de sténose de l'artère rénale
- C- Un régime sans sel
- D- La prescription de Furosémide
- E- Des apports hydriques libres

CAS CLINIQUE N°5

Un patient âgé de 60 ans aux antécédents de goutte traitée par purinol arrêté pendant deux semaines puis repris, c'est présenté aux urgences devant une asthénie des vomissements et une diminution de la diurèse.

Examen trouve un patient : fièvre à 38°C, TA 130/70 couché et debout, Bu : P+, H++, L-+++

Biologie : créatinine :650 µmol/l , Urée 32 mmol/l, NFS : GB 5600 (PNN 55% , LYMPHOCYTES 25%; éosinophiles 20%) ,hémoglobine 12 g/dl ,Plaquettes 175000

ECBU : L 100 E/mm³ ; H80 E/mm³, culture négative.

Protéinurie à 1 g /24 heures.

Écho rénale : reins à 14cm sans dilatation des CPC.

1. Quelle est l'étiologie de cette insuffisance rénale ?

- A. Insuffisance rénale fonctionnelle
- B. Néphropathie vasculaire aigue
- C. Néphropathie interstitielle aigue
- D. Néphropathie glomérulaire aigue
- E. Nécrose tubulaire aigue

2. Les arguments en faveur de ce diagnostic sont :

- A. Fièvre
- B. La leucocyturie
- C. Les vomissements
- D. La prise de purinol
- E. La taille des reins à l'échographie

3. Les signes biologiques en faveur de ce diagnostic sont :

- A. La leucocyturie
- B. Protéinurie à 1 g /24 heures
- C. Hématurie à 80/mm³
- D. Numération formule sanguine
- E. Le taux de créatinine

4. Si une ponction biopsie rénale est réalisée, que montre-elle ?

- A. Infiltrat interstitiel
- B. Œdème interstitiel
- C. Prolifération endocapillaire
- D. Prolifération extracapillaire
- E. Nécrose fibrinoïde

5. La conduite thérapeutique pour ce patient :

- A. Hémodialyse en urgence
- B. Arrêt Purinol
- C. Corticothérapie
- D. Prescription d'un antihypertenseur
- E. Échanges plasmatiques

CAS CLINIQUE N°6

Un homme de 50 ans, avec des antécédents de lithiases urinaires, consulte aux urgences pour colique néphrétique, évoluant depuis 24 heures. Il signale des nausées sans vomissements ni fièvre. Il n'a pas uriné depuis 12 heures.

À l'arrivée aux urgences

- TA : 140/85 mmHg, FC : 95 bpm, Température : 37,2 °C
- Examen clinique : douleur à la percussion lombaire droite
- Sonde urinaire: pas d'urines

Biologie initiale : Créatinine : 220 µmol/L, Kaliémie : 4,8 mmol/L, Bicarbonates : 20 mmol/L

1) Quel examen d'imagerie faut-il réaliser en urgence ?

- A. Scanner abdominal avec injection
- B. Échographie rénale
- C. Urographie intraveineuse (UIV)
- D. Radiographie de l'abdomen sans préparation (AUSP)
- E. IRM abdomino-pelvienne

Biologie de contrôle réalisé après quelques heures : Créatinine : 520 µmol/L Kaliémie : 7,8 mmol/L Bicarbonates : 7 mmol/L

Échographie rénale : Calcul obstructif droit de 10 mm avec dilatation pyélocalicielle droite
Rein gauche non visualisé,

2) Quelle(s) prise(s) en charge immédiate(s) recommandez-vous dans ce contexte ?

- A. hémodialyse en urgence
- B. Prescription de diurétiques de l'anse par voie intra-veineuse
- C. Alcalinisation des urines par bicarbonates de sodium par voie intra-veineuse

D. Administration de gluconate de calcium par voie intra-veineuse lente

E. administration de résine échangeuse d'ions : Kayexalate

3) Concernant la cause de cette insuffisance rénale aiguë, quelle proposition est exacte ?

A. Il s'agit d'une IRA obstructive par obstacle unilatéral sur rein unique

B. Il s'agit d'une IRA par rétention urinaire aiguë avec globe vésical

C Il s'agit d'une IRA obstructive par obstacle bilatéral

D. Elle est secondaire à une néphrite interstitielle aiguë

E. Elle est secondaire à une pyélonéphrite aiguë

4) Quelle est l'attitude thérapeutique dans ce contexte ?

A. Drainage des voies urinaires par néphrostomie percutanée droite ou Pose d'une sonde double J droite

B. Diurétiques

C. Antibiothérapie

D. Cathéter sus -pubien

E. Lithotritie extra-corporelle

CAS CLINIQUE N°7

Un homme de 65 ans, aux antécédents d'hypertension artérielle et d'adénome de la prostate, consulte pour une anurie totale depuis 24 heures. Il présente des douleurs hypogastriques. Pas de fièvre.

Examen clinique :

TA : 160/90 mmHg, FC : 88 bpm

Globe vésical à la palpation

Pas de douleur lombaire

Biologie : Créatinine : 450 $\mu\text{mol/L}$ (normale : 60-110), Kaliémie : 5,6 mmol/L, Bicarbonates : 16 mmol/L

Échographie : Vessie distendue ($> 1000 \text{ mL}$) ,Rein droit : dilatation modérée des cavités, Rein gauche : normal

1) Quelle est la cause la plus probable de cette IRA ?

A. Obstruction urétrale (adénome de prostate)

- B. Calcul urétéral bilatéral
- C. Néphrite interstitielle
- D. Glomérulonéphrite aiguë
- E. Pyélonéphrite

2) Quelle est la prise en charge urgente ?

- A. Pose d'une sonde urinaire
- B. Néphrostomie percutanée
- C. Diurétiques de l'anse
- D. Alcalinisation des urines
- E. Scanner abdomino-pelvien

3) Quels risques immédiats sont à craindre ?

- A. Rupture vésicale
- B. Hyperkaliémie sévère
- C. Acidose métabolique
- D. Choc septique
- E. Infarctus rénal

CAS CLINIQUE N°8

Une femme de 40 ans, sans antécédents, consulte pour des douleurs lombaires bilatérales et une oligurie progressive depuis 3 jours. Elle a des antécédents de fibrose rétropéritonéale.

Examen :

TA : 150/80 mmHg, FC : 90 bpm

Douleur à la percussion lombaire bilatérale

Biologie :

Créatinine : 600 µmol/L

Kaliémie : 6,0 mmol/L

CRP : 45 mg/L

Scanner abdominal : Dilatation bilatérale des voies urinaires, Fibrose rétropéritonéale englobant les uretères

1) Quel est le mécanisme de l'IRA ?

- A. Obstruction bilatérale par fibrose
- B. Néphropathie tubulo-interstitielle
- C. Glomérulonéphrite
- D. Thrombose des artères rénales
- E. Infection urinaire haute

2) Quelle(s) est la prise(s) en charge ?

- A. Pose de sondes double J bilatérales
- B. Néphrostomie percutanée
- C. Traitement par corticoïdes
- D. Hémodialyse en urgence
- E. Antibiothérapie probabiliste